

1) Introducción y relevancia clínica

Se denomina **abdomen agudo** al **dolor abdominal de inicio reciente** (habitualmente <72 h) **potencialmente quirúrgico**, asociado a signos de **inflamación peritoneal, obstrucción, isquemia o perforación**. Es una **urgencia diagnóstica**: el retraso en reconocer un foco quirúrgico (**apendicitis, colecistitis, oclusión intestinal, úlcera perforada, isquemia mesentérica, AAA**) se asocia a **sepsis, falla multiorgánica y muerte**. A la vez, un número no menor de pacientes presenta **cuadros no quirúrgicos** (cólicos renales, gastroenteritis, causas ginecológicas), por lo que el desafío es **decidir quién necesita cirugía inmediata, estudio dirigido u observación**.

Claves para EUNACOM y práctica:

- Evaluar **constantes vitales** y **red flags** desde el primer contacto (no “analgesiar y ver” sin examinar).
- Diferenciar **peritonitis** de **dolor visceral/cólico**.
- Indicar **imágenes apropiadas** (eco vs TAC con contraste) según **sospecha y edad**.
- **No retrasar antibióticos** ante sospecha de foco intraabdominal complicado.
- En mujeres en edad fértil: **descartar embarazo ectópico** siempre.

2) Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Tipos de dolor abdominal

- **Visceral**: fibras C; **sordo, mal localizado**, línea media, asociado a **distensión o isquemia** (ej. cólico biliar, gastroenteritis inicial).
- **Somático (parietal)**: fibras A-δ; **intenso, bien localizado**; por **irritación peritoneal** (ej. apendicitis evolucionada, perforación).
- **Referido**: dolor percibido a distancia por convergencia de aferencias (ej. **hombro derecho** en irritación diafragmática por colecistitis; **dorso** en pancreatitis).

2.2 Síndromes fisiopatológicos mayores

- **Inflamación/infección:** apendicitis, colecistitis, diverticulitis → dolor progresivo + fiebre + leucocitosis.
 - **Obstrucción luminal:** adherencias, hernias, neoplasias → **dolor cólico, vómitos, distensión, ausencia de deposiciones/gases.**
 - **Isquemia/infarto:** isquemia mesentérica, torsión ovárica, AAA roto → **dolor desproporcionado** a examen, acidosis láctica, shock.
 - **Perforación:** úlcera péptica, divertículo → **dolor súbito** + abdomen en tabla + **neumoperitoneo.**
 - **Cólico urológico:** obstrucción ureteral con dolor **lumboflanco a ingle**, hematuria.
 - **Causas ginecológicas:** embarazo ectópico, torsión ovárica, EIP.
-

3) Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Anamnesis dirigida

- **Inicio:** súbito (perforación, isquemia), insidioso (inflamatorio).
- **Localización:** migración **epigastrio** → **FID** (apendicitis), HCD (colecistitis), epigastrio en cinturón a dorso (pancreatitis), FII (diverticulitis).
- **Caracter:** cólico (obstrucción, cólico biliar/renal) vs continuo (peritonitis).
- **Síntomas asociados:** fiebre, náuseas/vómitos biliosos o fecaloídeos, **íleo** (no gases ni deposiciones), diarrea, **ictericia** (coledocolitiasis), **disuria/hematuria** (renal), **metrorragia/amenorrea** (ginecológico).
- **Antecedentes clave:** cirugías previas (adherencias), hernias, diverticulosis, AINEs (úlceras), FA/aterosclerosis (isquemia), alcohol/litiasis (pancreatitis), edad >65 (AAA, isquemia), **mujer en edad fértil** (ectópico, EIP).

3.2 Examen físico

- **Signos vitales:** fiebre, taquicardia, hipotensión, taquipnea.
- **Inspección:** distensión, cicatrices, hernias, respiración superficial.

- **Auscultación:** ruidos aumentados y de “lucha” (obstrucción temprana), **ausentes** (íleo/parálisis, peritonitis).
- **Palpación:** dolor localizado; **defensa** y **rigidez** = irritación peritoneal; **Blumberg** (+) rebote; **Murphy** (+) colecistitis; **McBurney/Rovsing** apendicitis.
- **Percusión:** timpanismo (distensión), dolor a la descompresión.
- **Tacto rectal:** dolor a fondo de saco, masa, sangre (selectivo, con indicación).
- **Examen ginecológico** si corresponde (dolor anexial, flujo, masa).

3.3 Diagnóstico diferencial por cuadrante (orientativo)

Hipocondrio derecho (HCD)

- **Colelitiasis/colecistitis**, colangitis, hepatitis, absceso hepático, neumonía basal derecha.

Epigastrio

- **Úlcera péptica** (incluye perforación), **pancreatitis**, IAM inferior, gastritis, esofagitis.

Hipocondrio izquierdo

- Esplenitis/esplenomegalia dolorosa, gastritis, pancreatitis (cola), neumonía basal izquierda.

Fosa ilíaca derecha (FID)

- **Apendicitis**, adenitis mesentérica, Crohn, **embarazo ectópico derecho**, EIP, cólico ureteral.

Fosa ilíaca izquierda (FI)

- **Diverticulitis**, colon irritable, colitis, cólico ureteral, **embarazo ectópico izquierdo**.

Mesogastrio/hipogastrio

- **Obstrucción intestinal**, hernias incarceradas, íleo, ITU, retención urinaria, patología ginecológica (miomas, torsión ovárica, EIP).

Dorso en cinturón

- **Pancreatitis aguda**, aneurisma de aorta abdominal (AAA), cólico renal.

3.4 Cuadros “must know” (resumen clínico rápido)

- **Apendicitis aguda**: dolor periumbilical que migra a FID, anorexia, náuseas, fiebre baja; signos de Blumberg, Rovsing, psoas/obturador (+).
 - **Colecistitis aguda**: dolor HCD >6 h, fiebre, vómitos, **Murphy (+)**; a veces ictericia (si coledocolitiasis).
 - **Pancreatitis aguda**: dolor epigástrico transfixiante al dorso, náuseas intensas; aumenta con decúbito, cede al inclinarse; amilasa/lipasa ↑.
 - **Obstrucción intestinal**: dolor cólico, vómitos (precoces si alta), **distensión, no eliminación de gases**; RHA de lucha o silencio (tardío).
 - **Úlcera péptica perforada**: dolor súbito intenso, abdomen en tabla, neumoperitoneo.
 - **Isquemia mesentérica**: **dolor desproporcionado** al examen, riesgo vascular, lactato ↑; diarrea/sangre ocasional; evolución a peritonitis.
 - **Diverticulitis**: FII dolor + fiebre, cambio del hábito intestinal; defensa localizada; complicación: absceso/perforación.
 - **AAAbd (rotura)**: dolor dorsal/abdominal súbito, hipotensión, masa pulsátil; varones >65 con tabaquismo.
 - **Cólico renal**: dolor lumboflanco a ingle, **inquietud**, hematuria.
 - **Ectópico roto**: dolor pélvico, amenorrea, sangrado vaginal, hipotensión; test embarazo positivo.
 - **EIP**: dolor pélvico bilateral, fiebre, leucorrea, dolor a movilización cervical.
-

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio inicial (urgencia)

- **Hemograma** (leucocitosis con desviación izquierda → inflamación/infección; Hb/Hto en hemorragia).
- **PCR** (evolución y severidad; no sustituye clínica).

- **Electrolitos, urea, creatinina** (función renal y volemia).
- **Pruebas hepáticas** (BT, FA, GGT, TGO/TGP) y **amilasa/lipasa** (pancreatitis; **lipasa es más específica**).
- **Lactato** (isquemia/sepsis).
- **EGO** (hematuria en cólico renal; ITU).
- **Test de embarazo en toda mujer en edad fértil** (¡siempre!).

4.2 Imágenes: elegir bien

Ecografía abdominal

- Primera línea en **patología biliar** (colecistitis: engrosamiento pared >3 mm, litiasis, Murphy ecográfico).
- Útil en **hidronefrosis** (cólico renal), **apendicitis** en pediatría y delgados, **líquido libre**.
- Ventajas: **no radiación**, accesible, al lado de la cama.

TAC de abdomen y pelvis con contraste (estándar en adulto)

- Gold standard en **abdomen agudo no filiado**.
- **Apendicitis** (apéndice >6 mm, grasa pericecal), **diverticulitis** (engrosamiento + estriación grasa), **obstrucción** (nivel hidroaéreo, punto de transición), **isquemia** (realce mucoso disminuido, neumatosis), **perforación** (neumoperitoneo) y **abscesos**.
- En **insuficiencia renal** o alergia: protocolos con **contrastes alternativos** o **TAC sin contraste** según sospecha.

Radiografía de abdomen/tórax

- Hoy menos usada, pero puede mostrar **niveles hidroaéreos** (oclusión), **neumoperitoneo** subdiafragmático.
- Rx tórax útil si sospecha **neumonía** como dolor referido.

AngioTAC

- Esencial en **isquemia mesentérica** y **AAA**.

RM

- En embarazo (cuando eco no concluyente) y en **colangioresonancia** si duda de coledocolitiasis (no es de urgencia inmediata si paciente estable).

4.3 Herramientas clínicas útiles

- **Alvarado/AIR score** (apendicitis): ayudan, pero **no sustituyen** clínica/imágenes.
- **qSOFA/SOFA** si sospecha sepsis.
- **Glasgow-Imrie** y **BISAP** (pancreatitis) para severidad.

4.4 Criterios prácticos de “quirúrgico vs no quirúrgico”

- **Peritonitis franca** (defensa/rigidez generalizada, rebote) → **evaluación quirúrgica inmediata**.
- **Obstrucción con compromiso** (dolor persistente, leucocitosis, lactato ↑, fiebre, dolor en reposo) → **cirugía**.
- **Perforación** (neumoperitoneo) → **cirugía**.
- **Isquemia mesentérica** (angioTAC alterado, dolor desproporcionado) → **revascularización/laparotomía**.
- **Colecistitis/ apendicitis** no complicadas → **cirugía temprana**, no demorar innecesariamente.

5) Tratamiento (según guías quirúrgicas/urgencia)

Principio rector: **reanimación – diagnóstico – control del foco** (quirúrgico o percutáneo) + **antibióticos cuando corresponde**.

5.1 Manejo inicial universal (sala ERA/Urgencia)

1. **ABC**: vía aérea, oxigenoterapia si $\text{SatO}_2 < 94\%$.

2. **Vía venosa gruesa (2) + fluidos:** cristaloides balanceados si hipotensión/taquicardia/lactato ↑.
3. **Analgesia temprana** (opioide + paracetamol ± AINE si no contraindica). La analgesia **no enmascara** signos y mejora evaluación.
4. **Antieméticos** si vómitos.
5. **SNG** en **oclusión alta** o vómitos persistentes; **sonda vesical** si shock/oliguria.
6. **Antibióticos empíricos** ante **sospecha de foco intraabdominal complicado** (peritonitis, absceso, diverticulitis complicada, apendicitis/perforación, colangitis): opciones típicas hospitalarias incluyen **ceftriaxona + metronidazol** o **piperacilina/tazobactam** según severidad y contexto local.
7. **Laboratorio + imágenes dirigidas** según sospecha.

5.2 Conductas específicas (panorama en 1 página)

- **Apendicitis aguda:** apendicectomía temprana (ideal laparoscópica). Antibiótico perioperatorio; terapéutico si perforada/absceso.
- **Colecistitis aguda:** **colecistectomía precoz (24–72 h)**; si alto riesgo o séptica (Tokyo), considerar **drenaje percutáneo** y antibióticos.
- **Colangitis aguda:** antibióticos + **CPRE urgente (drenaje biliar)**.
- **Obstrucción intestinal:**
 - **Adherencial** sin signos de estrangulación: manejo conservador (SNG, fluidos, analgesia, vigilancia); si no resuelve 24–48 h o empeora → cirugía.
 - **Hernia incarcerada/estrangulada** o **signos de sufrimiento** (dolor en reposo, fiebre, lactato ↑, leucocitosis): **cirugía urgente**.
- **Úlcera péptica perforada:** reanimación + antibióticos + **cirugía** (cierre + parche epiplón) y erradicar *H. pylori* luego.
- **Diverticulitis:**
 - **No complicada:** antibióticos (según práctica local; algunos casos seleccionados pueden ser sin antibióticos), reposo digestivo, control ambulatorio/hospitalario según dolor/comorbilidades.
 - **Complicada (absceso, perforación, peritonitis):** drenaje percutáneo o **cirugía** (Hartmann/resección).

- **Pancreatitis aguda:** reposo digestivo, fluidos, analgesia; **no antibióticos de rutina;** TAC si duda o mala evolución; manejo de complicaciones (necrosis infectada → drenaje/endoscópico/cirugía).
 - **Isquemia mesentérica:** reanimación + antibióticos + **angiografía/angioTAC;** **revascularización** (endovascular/quirúrgica) y **resección** de intestino necrótico.
 - **AAA roto:** protocolos de shock hemorrágico + **reparación urgente** (endovascular/abierta).
 - **Cólico renal:** analgesia (AINEs/opioides), hidratación; imágenes; urología si fiebre (obstrucción infectada → **drenaje urgente**).
 - **Ectópico:** U de emergencia/GO: **metrotexato** (seleccionados) o **cirugía;** reanimación si inestable.
 - **EIP:** antibióticos de amplio espectro; UGO valoración.
-

6) Complicaciones y pronóstico

- **Sepsis y shock séptico** por perforación/isquemia/colecistitis complicada.
- **Falla multiorgánica** si diagnóstico tardío.
- **Síndrome compartimental abdominal** en reanimaciones masivas.
- **Fístulas, abscesos, dehiscencias** posoperatorias.
- **Mortalidad:** depende de la etiología y del **tiempo a control del foco** (esencial en isquemia, perforación, colangitis, AAA).

Factores de mal pronóstico: edad avanzada, comorbilidades (DM, ERC, cardiopatía), **lactato alto persistente**, hipotensión refractaria, retraso en drenaje/cirugía, bacteriemia por bacilos Gram negativos o anaerobios.

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas

1. **Analgesia temprana** mejora la evaluación; **no “esconde”** abdomen agudo.

2. **Test de embarazo a toda mujer en edad fértil**, independiente de relato.
3. **Peritonitis** = **cirugía** hasta demostrar lo contrario.
4. **Dolor desproporcionado + FA o aterosclerosis** → piensa en **isquemia mesentérica** (pide **angioTAC**).
5. **Colecistitis**: eco es **estudio de elección**; **Murphy ecográfico** aumenta rendimiento.
6. **Obstrucción**: buscar **punto de transición** en TAC y **estrangulación** (lactato, fiebre, dolor en reposo).
7. **Colangitis**: tríada de Charcot (fiebre, ictericia, dolor HCD) ± shock/alteración mental (péntada de Reynolds) → **antibióticos + drenaje biliar (CPRE)**.
8. **Úlcera perforada**: Rx tórax de pie puede mostrar aire subdiafragmático; TAC confirma y planifica cirugía.

□ Errores frecuentes

- Retrasar imágenes/antibióticos en **paciente tóxico**.
- No repetir examen físico seriado (el abdomen **cambia**).
- Considerar “gastroenteritis” sin sólidos **signos sistémicos** o **brotos**; descartar **apéndice/divertículo** primero.
- Abusar de **opioides** sin plan diagnóstico ni reevaluación.
- Omitir **exploración de hernias** y cicatrices (causas de oclusión).
- Desestimar **dolor + lactato** normal: la isquemia mesentérica puede debutar **con lactato normal** precozmente.
- Dar de alta con “dolor abdominal funcional” **sin vigilancia** ni criterios claros.

8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Abdomen agudo** es un síndrome *tiempo-dependiente*: **peritonitis, obstrucción complicada, perforación e isquemia** requieren **cirugía/drenaje** precoz.

2. Diferencia **dolor visceral** (cólico, difuso) de **somático** (localizado, peritoneal).
3. **Laboratorio básico + Eco/TAC dirigidos** según sospecha; **eco** para biliar/uro; **TAC con contraste** es el estándar en adulto incierto.
4. **Manejo inicial**: ABC, cristaloides, analgesia, antieméticos, **antibiótico** si sospecha intraabdominal complicado.
5. **Apendicitis y colecistitis**: resolución quirúrgica temprana; **colangitis** exige **drenaje biliar**.
6. **Isquemia mesentérica/AAA**: **angioTAC** y **control vascular** urgentes; el dolor puede ser **desproporcionado** a examen.
7. En toda mujer en edad fértil: **descarta embarazo ectópico** (test de embarazo **obligatorio**).